

सुप्राप्यूबिक कैथेटर प्लेसमेंट

रोगी जानकारी • प्रक्रिया से पहले क्या उम्मीद करें

WARWIKI

सुप्राप्यूबिक कैथेटर — जिसे **suprapubic tube** या “**SPT**” भी कहते हैं — एक मुलायम tube है जो पेट के नीचे, **pubic bone** के ऊपर, एक छोटे से छेद से मूत्राशय (bladder) का पेशाब बाहर निकालती है — मूत्रमार्ग (urethra) की जगह। यह handout बताता है कि यह क्यों लगाई जाती है, कैसे तैयारी करें, और क्या होता है।

इस प्रक्रिया के बारे में

मूत्राशय (bladder) पेशाब जमा करता है। जब पेशाब सामान्य रास्ते से नहीं निकल सकता — या मूत्रमार्ग (urethra) को आराम देना जरूरी हो — तो catheter सीधे पेट से bladder में डाली जाती है। यह urethra को bypass करती है, इसलिए लंबे समय तक उपयोग के लिए अधिक आरामदायक होती है।

आपकी चिकित्सा टीम SPT की सलाह दे सकती है:

- जब आप खुद bladder खाली न कर पाएँ
- सर्जरी या चोट के बाद urethra को आराम देने के लिए
- तंत्रिका (nerve) संबंधी bladder की स्थिति में लंबे समय तक drainage के लिए
- urethra से catheter की जलन से बचने के लिए
- सामान्य यौन गतिविधि और “voiding trial” (tube को बंद कर पेशाब की जाँच) की सुविधा के लिए

क्या यह सुरक्षित है?

हाँ। यह एक सामान्य और आमतौर पर सुरक्षित प्रक्रिया है। Bladder को पानी से भरा जाता है ताकि वह पेट की दीवार से सट जाए। टीम ultrasound और/या छोटे camera से tube को आँत से दूर सही जगह पहुँचाती है। अधिकतर समस्याएँ — थोड़ा रक्तस्राव, हल्का दर्द, या bladder में ऐंठन — मामूली होती हैं। यदि पहले कोई पेट या पेल्विक सर्जरी हुई हो, तो टीम को बताएँ।

शब्दों को समझें

Suprapubic

Pubic bone के ऊपर, पेट के निचले हिस्से में — जहाँ tube बाहर निकलती है।

Bladder (मूत्राशय)

वह अंग जो पेशाब जमा करता है।

Catheter

पेशाब निकालने वाली मुलायम tube। Suprapubic catheter पेट से निकलती है, urethra से नहीं।

Urethra (मूत्रमार्ग)

वह tube जो सामान्यतः पेशाब बाहर ले जाती है। SPT इसे bypass करती है।

Local anesthetic

त्वचा में दी जाने वाली सुन्न करने वाली दवा।

Sedation / anesthesia

आपको आराम देने या सुलाने वाली दवा।

Ultrasound / camera

ध्वनि-तरंग imaging या bladder में छोटा camera — tube को सही जगह लगाने के लिए।

Bladder spasm

Bladder में अचानक ऐंठन — बाद में सामान्य है और इलाज हो सकता है।

क्या इसमें दर्द होगा? यह approach पर निर्भर करता है: कुछ placements में numbing दवा और sedation दी जाती है; कई में **general या spinal anesthesia** होता है — आप सोए रहते हैं या सुन्न रहते हैं। आपकी टीम बताएगी। बाद में bladder में हल्की ऐंठन या site पर दर्द सामान्य है। प्रक्रिया लगभग 15–30 मिनट लेती है।

तैयारी कैसे करें (प्रक्रिया से पहले)

- **कहा जाए तो भरे bladder के साथ आएँ** — इससे placement सुरक्षित होती है। टीम आपको पानी पिलाकर रोक सकती है, या शुरुआत में bladder भर सकती है।
- **Fasting के निर्देश मानें** — sedation या general anesthesia हो तो कई घंटे पहले से खाना-पीना बंद करना पड़ सकता है।
- **Sedation होगी तो घर ले जाने की व्यवस्था करें।**

टीम को पहले से बताएँ यदि:

- पहले कोई **पेट या पेल्विक सर्जरी** हुई हो — निशान (scar) से tube का रास्ता बदल सकता है
- आप **blood thinner** लेते हों या रक्तस्राव की समस्या हो — अक्सर प्रक्रिया से पहले बंद कराई जाती है
- गर्भावस्था की संभावना हो, या कोई infection, anesthetic या latex से allergy हो

प्रक्रिया के दौरान क्या होता है

- 1 आपको लिटाया जाता है और anesthesia दी जाती है — numbing दवा + sedation, या general/spinal anesthesia। पेट का निचला हिस्सा साफ किया जाता है।
- 2 Bladder को fluid से भरा जाता है (यदि पहले से नहीं भरा) ताकि वह पेट की दीवार से लग जाए और आँत से दूर हो।
- 3 Ultrasound और/या bladder में छोटे camera की मदद से, टीम pubic bone के ठीक ऊपर एक छोटा-सा चीरा लगाकर tube bladder में डालती है।
- 4 Bladder के अंदर एक छोटा balloon फुलाकर tube को जगह पर रखा जाता है और drainage bag से जोड़ा जाता है।

बाद में

- पेशाब bag में जमा होगा। टीम आपको **tube और skin site की देखभाल** सिखाएगी।
- एक-दो दिन हल्का दर्द, bladder में ऐंठन, या **पेशाब में थोड़ा खून** सामान्य है।
- **पहला tube बदलाव आपकी टीम करती है**, लगभग 4–6 हफ्ते बाद। Tube निकल जाए तो तुरंत टीम से संपर्क करें — रास्ता घंटों में बंद हो सकता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- Tube **निकल जाए** या drainage बंद हो जाए (bag में पेशाब न आए)
- पेट में बढ़ता दर्द, सूजन, या अधिक रक्तस्राव
- पेशाब का गंदला या बदबूदार होना (संक्रमण का संकेत)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. SPT पेट के निचले हिस्से में एक छोटे छेद से bladder का पेशाब निकालती है — urethra को bypass करती है और लंबे समय के लिए अधिक आरामदायक होती है।
2. तैयारी: कहा जाए तो भरे bladder के साथ आएँ, fasting मानें, sedation हो तो ride की व्यवस्था करें, और पेट की पुरानी सर्जरी, blood thinners या गर्भावस्था की संभावना टीम को बताएँ।
3. Numbing दवा + sedation या general anesthesia में होती है। टीम tube care सिखाती है और 4–6 हफ्ते में पहला बदलाव करती है। Tube निकले, बुखार आए, या पेशाब बंद हो — तुरंत फोन करें।